

Chap5-10. 장 기능이상 기초 검사 Part 5

Foundational Laboratory Evaluation of Gut Dysfunction Part 5 | AFMCP Chap5

1. 검사 결과 통합 해석

개별 검사 결과보다 여러 검사를 통합적으로 해석하는 것이 더 중요합니다. 단일 마커의 이상보다 여러 마커가 일관된 패턴을 보일 때 임상적 의의가 높습니다. 기능의학적 해석은 "정상 참고 범위" 내에 있어도 최적 범위가 아닐 수 있음을 고려합니다.

2. 장 기능이상 패턴 인식

패턴	관련 검사 이상	주요 임상 의심
소화 불량 패턴	낮은 HCl 반응, 낮은 췌장 엘라스타아제, 지방변	위산 저하, 췌장 기능 저하
이상균총 패턴	SIBO 호기 검사 양성, 유해균 증가, 유익균 감소	항생제/약물 남용, 식이 문제
장 염증 패턴	칼프로텍틴 상승, sIgA 변화, hsCRP 상승	IBD, 감염, 음식 민감성
장 투과성 패턴	존놀린 상승, 락툴로스/만니톨 비율 증가, IgG 음식 반응 증가	자가면역 위험, 독소 노출, 스트레스
영양 결핍 패턴	B12, 철분, D, 아연 저하	흡수 불량, 소화 불량

3. 검사 순서 및 비용 효율적 접근

1차 평가 (모든 환자)

- CBC + 포괄적 대사 패널
- 비타민 B12, 엽산, 비타민 D
- 철분 패널(혈청 철, 페리틴, TIBC)
- 갑상선 기능(TSH + 유리 T4)
- hsCRP

2차 평가 (소화 증상 있는 환자)

- CDSA(포괄적 대변 분석)
- H. pylori 검사(UBT 또는 대변 항원)
- SIBO 호기 검사(수소+메탄)
- 셀리악병 스크리닝(anti-tTG IgA + 총 IgA)

3차 평가 (복잡한 사례)

- 음식 민감성 패널(IgG/IgA)
- 장 투과성 검사(락툴로스/만니톨, 존놀린)
- 유기산 검사(OAT)

- 미생물 유전체 분석

4. 추적 검사 계획

치료 효과를 모니터링하기 위한 추적 검사 계획을 수립합니다. 일반적으로 치료 시작 후 8-12주에 주요 마커를 재검사합니다. 증상 개선과 검사 지표 정상화가 함께 이루어지는지 확인합니다.

- CDSA: 치료 후 미생물 변화 확인
- SIBO 호기 검사: 치료 2주 후 재검사
- 영양 패널: 보충 8-12주 후 재검사
- 증상 일지: 객관적인 치료 반응 추적